

JUNIOR DALALIO DO NASCIMENTO

HD: AOS + HAS + Colesterol
 MEDICO: Dr. Centro Con.
 MEDICAMENTOS:
 IMC: Peso = ~~altura~~ altura =
 CIRCUNF. DE PESCOÇO
 PA:
 OXIMETRIA: masc (m).

11/03/26 ele deixou de utilizar por mais de 2 anos, relata que sente muito desconforto, mas a máscara estava muito desagradável.

Ajusto a máscara D'ellow e o CPAP com P = 4-10 cmH₂O APÉ só na rampa umidif. 6. Troco o filtro. ————— Sue

- Dorme: 00:00 Acorda: 4hr.
- Banheiro a noite 1x
- Relata cansaço; sonolência;
- Exercício físico: bicicleta e esteira 30 min. todos os dias.
- Nega outras patologias

Nome: JUNIOR DALALIO DO NASCIMENTO
Data de Nascimento: 11-11-1966
IMC: 29,07
Sexo: Masculino
Data do exame: 04-09-2021

Peso: 84 kg
Altura: 1,70 m
Médico: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 04-09-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 467,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,5 e 140,0 minutos. O tempo total de sono foi de 339,0, eficiência de 72,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 56,6%; estágio N3: 20,9%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 18,9/hora (normal < 10/h). O índice de apneia/hipopneia total foi de 24,2/hora, sendo elas 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 136 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 77%, permanecendo 4,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 43 - 87 bpm e NREM de 41 - 88 bpm.

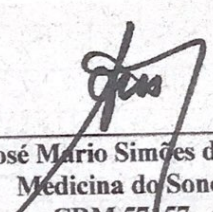
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (06), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (6,0/hora);
6. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57